

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 24/02/2026 09:47

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Parasitológico

DESCRIÇÃO:

vbh

OBSERVAÇÕES:

bn

RESULTADO:

****Relatório de Análise de Imagem Médica****

****1. Descrição da Imagem e Qualidade Técnica:****

A imagem apresentada é de um esfregaço de sangue periférico, provavelmente corado pelo método de Giemsa ou similar, sob alta magnificação (provavelmente imersão em óleo). A qualidade técnica da

imagem é boa, com coloração adequada, bom contraste e foco nítido, permitindo a visualização clara da morfologia dos eritrócitos e das estruturas parasitárias. O campo visual exibe uma população densa de glóbulos vermelhos.

****2. Achados Principais:****

* ****Presença de parasitas intraeritrocitários:**** Numerosos eritrócitos contêm estruturas parasitárias coradas em roxo, características de parasitas do gênero *Plasmodium*.

* ****Morfologia dos parasitas:**** A maioria dos parasitas observados são formas aneladas (trofozoítos jovens), que são pequenas, delicadas e possuem um ponto de cromatina e um anel de citoplasma.

* ****Múltiplas infecções por eritrócito:**** Em vários campos, é possível observar mais de um parasita anelado dentro de uma única hemácia.

* ****Formas "accolé" (appliqué):**** Alguns anéis parasitas são vistos aderidos à margem do eritrócito (forma accolé ou appliqué), uma característica comum.

* ****Eritrócitos parasitados:**** Os eritrócitos infectados não demonstram aumento significativo de tamanho ou alterações de forma discerníveis que sugiram outras espécies de *Plasmodium* (como *P. vivax* ou *P. ovale*).

* ****Parasitemia:**** A densidade de parasitas no campo visual é significativa, indicando uma parasitemia moderada a alta.

* ****Ausência de outras formas:**** Não são observadas formas mais maduras como esquizontes ou gametócitos em quantidade proeminente neste campo específico, o que é comum em infecções por *P. falciparum*, onde a maturação ocorre principalmente em órgãos internos.

****3. Diagnóstico Sugerido:****

Os achados morfológicos, incluindo a predominância de formas aneladas peq...

[Diagnóstico completo disponível no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:****

****1. Tratamento Antimalárico (a ser iniciado em ambiente hospitalar, preferencialmente):****

* ****Medicamento de Eleição para Malária Falciparum Grave ou com Sinais de Alerta:****

* ****ARTESUNATO INJETÁVEL (IV)**** - 2,4 mg/kg dose inicial, seguida de 2,4 mg/kg em 12h e depois 2,4 mg/kg a cada 24h, até o paciente ser capaz de tolerar a medicação oral.

* ****Via:**** Intravenosa.

* ****Duração:**** Conforme avaliação médica hospitalar, geralmente por no mínimo 24-48 horas ou até resolução dos sinais de gravidade, seguido de tratamento oral.

* ****Quantidade:**** A ser definida pela equipe hospitalar.

* ****Tratamento Oral (Caso o paciente não apresente sinais de malária grave, seja capaz de deglutir e esteja aguardando internação ou em locais onde o tratamento parenteral não seja prontamente disponível):****

* ****ARTEMETHER 20mg + LUMEFANTRINA 120mg**** (Nome Comercial Sugerido: Coartem® ou similar)

* ****Dosagem:**** 4 comprimidos (total 80mg Artemether / 480mg Lumefantrina)

* **Frequência:**

* 1ª dose: 4 comprimidos agora

* 2ª dose: 4 comprimidos após 8 horas

* 3ª dose: 4 comprimidos após 24 horas da 1ª dose

* 4ª dose: 4 comprimidos após 36 horas da 1ª dose

* 5ª dose: 4 comprimidos após 48 horas da 1ª dose

* 6ª dose: 4 comprimidos após 60 horas da 1ª dose

* **Duração do Tratamento:** 3 dias (6 doses no total).

* **Via:** Oral.

* **Quantidade Total a Dispensar:** 24 comprimidos.

* **Observação:** Ingerir com alimentos ricos em gordura (leite, iogurte, etc.) para melhor absorção.

2. Medicação Sintomática (se necessário):

* **PARACETAMOL 500 mg** (Nome Comercial: Tylenol®, Cimegripe®, ou similar)

* **Dosagem:** 1 comprimido (500mg).

* **Frequência:** A cada 6 ou 8 horas, se necessário, para febre e/ou dor de cabeça.

* **Duração do Tratamento:** Enquanto os sintomas persistirem.

* **Via:** Oral.

* **Quantidade Total a Dispensar:** 12 comprimidos (para 3-4 dias).

1. **INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA:** Este é o passo mais crítico e imediato. O paciente Xavier Tchivela deve ser internado imediatamente em unidade hospitalar para avaliação clínica completa, confirmação da extensão da parasitemia, monitoramento de sinais de gravidade e início do tratamento antimalárico adequado.
2. **AValiação por Especialista:** Recomendada avaliação por médico infectologista para manejo da Malária por *P. falciparum*.
3. **MONITORAMENTO CLÍNICO:** Monitorar rigorosamente sinais vitais, nível de consciência, sinais de insuficiência respiratória, renal, hepática e anemia severa.
4. **EXAMES COMPLEMENTARES NA INTERNAÇÃO:**
 - * Hemograma Completo (para avaliar anemia e plaquetopenia).
 - * Função Renal (Creatinina, Ureia).
 - * Função Hepática (Transaminases, Bilirrubinas).
 - * Eletrólitos e Glicemia.
 - * Gasometria Arterial (se houver sinais de comprometimento respiratório).
 - * Repetição de Gota Espessa e Esfregaço Fino para quantificação precisa da parasitemia e confirmação da espécie.
5. **HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO:** Manter hidratação adequada (oral ou intravenosa, conforme a necessidade) e suporte nutricional.
6. **SINAIS DE ALERTA PARA RETORNAR AO MÉDICO (URGÊNCIA):**
 - * Piora da febre e calafrios intensos.
 - * Alteração da consciência, confusão mental, convulsões.
 - * Dificuldade para respirar ou respiração rápida.
 - * Fraqueza extrema ou incapacidade de se mover.
 - * Urinar pouco ou urina de cor escura ("chá preto").
 - * Amarelamento da pele e dos olhos (icterícia).

* Sangramentos inesperados.

7. ****REAValiação:**** O acompanhamento deve ser diário em ambiente hospitalar, com reavaliação da parasitemia através de exames laboratoriais até a negatificação.

8. ****Repouso:**** Repouso relativo enquanto sintomático e durante o período de internação.

* ****INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**** Informar a equipe médica sobre quaisquer outros medicamentos que o paciente esteja utilizando, incluindo fitoterápicos e suplementos. Particular atenção deve ser dada a medicamentos que prolongam o intervalo QT, como certos antiarrítmicos, antidepressivos e antibióticos.

* ****EFEITOS COLATERAIS COMUNS (Artemether/Lumefantrina):**** Dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, dores musculares e nas articulações, fadiga. A ocorrência de efeitos adversos graves deve ser comunicada imediatamente à equipe médica.

* ****COMPLETUDE DO TRATAMENTO:**** É crucial completar todo o curso do tratamento antimalárico, mesmo que os sintomas melhorem antes do término da medicação, para garantir a erradicação do parasita e prevenir recidivas ou o desenvolvimento de resistência.

* ****ARMAZENAMENTO:**** Manter os medicamentos em suas embalagens originais, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegidos da luz e umidade. Manter fora do alcance de crianças.

****Dr. Fernando****

[Assinatura do Médico]

[Carimbo do Consultório/Hospital]

[Informações de Contato: Telefone, Endereço, E-mail (se aplicável)]

RECOMENDAÇÕES

****RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS:****

****OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:****

* ****MALÁRIA FALCIPARUM:**** Esta forma de malária é a mais grave e pode levar a complicações sérias como malária cerebral, anemia grave, insuficiência renal aguda, edema pulmonar, choque e óbito, se não tratada prontamente e adequadamente.

* ****CONTRAINDICAÇÕES:**** Hipersensibilidade conhecida a artemether, lumefantrina, artesunato ou a qualquer excipiente das formulações.

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando
CRM: sfgh
radiologista

Receita gerada em 24/02/2026 09:47
ID da receita: 2
Sistema Médico - Receita eletrônica